build_recent packages 1-3

tolletaten_seniorradgiver_prosessledelse_endring (r20260920-212518-413d77)

cv 1

VEGARD HÅLAND

SAMFUNNSØKONOM | PROSESSFORBEDRING, STYRING OG KONTROLLERT DIGITALISERING

Oslo | +47 905 26 886 | vegard-haaland@outlook.com

PROFIL

Samfunnsøkonom med master fra NTNU og rådgiver i Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus. Jeg gjør uklare, tverrgående behov om til avgrensede leveranser: kartlegger aktører, ansvar, avhengigheter og beslutningsbehov, og følger arbeidet frem til kontrollert innføring og bruk. Jeg moderniserte sykehusets budsjetteringsverktøy og gjorde kodeendringene i en prosess med om lag 50 deltakere; verktøyet er i sykehusdekkende bruk. Jeg har også medutviklet et rammeverk for gevinstrealisering som ble innført som sykehusstandard, og utarbeider beslutnings- og ledelsesunderlag tilpasset ledere, controllere, fagmiljøer og tekniske miljøer.

KJERNEOMRÅDER Funksjonell prosess- og leveranseledelse i tverrfaglige oppdrag · Avklaring av behov, aktører, ansvar, avhengigheter og beslutningsbehov · Kontrollert endring: akseptansekriterier, paritets- og differansetesting, risiko- og gap-register · Gevinstrealisering, metodeutvikling og standardisering · Planlegging og fasilitering av workshops, onboarding og kompetanseoverføring · Beslutningsnotater og ledelsesunderlag tilpasset ulike mottakere · Økonomifaglig analyse av offentlige beslutninger, insentiver og avveininger · Power BI, DAX, Power Query, Excel/VBA, SQL og Python brukt til gjennomføring og kontroll

YRKESERFARING

Rådgiver Økonomi og IKT | Oslo universitetssykehus HF 03.2023-d.d.
Direktørens stab, Analyseavdelingen **12.2023-d.d.**

- Moderniserte sykehusets om lag 20 år gamle og virksomhetskritiske budsjetteringsverktøy: rekonstruerte arkitekturen fra kildekode, formler og navn, og integrerte ansatt-, ansettelses- og bemanningsdata som tidligere måtte kopieres manuelt. Om lag 50 personer deltok i arbeidsgrupper, kravarbeid og innføring, og jeg var i praksis eneste utvikler på kodeendringene.
- Gjennomførte endringene funksjon for funksjon under strenge kompatibilitets- og driftskrav, med differansesammenligning av opprinnelige og refaktorerte funksjoner, akseptansekriterier, eksplisitte paritetskrav og risiko- og gap-register. Verktøyet er i sykehusdekkende bruk i budsjettprosessene for 2026 og 2027.
- Medutviklet i en firepersonersgruppe et revidert rammeverk for gevinstrealisering og estimering. Rammeverket ble innført som sykehusstandard og var i bruk om lag 2,5 år senere.
- Utformet arbeidsprosesser, ansvarsdeling, avhengighetsoversikt og prioritering for avdelingen, og strukturerte inntaksskjemaer som fanger formål, brukere, beslutningsbehov, avhengigheter, risiko og akseptansekriterier. Enkelte arbeidsformer er innført, andre står som forslag.
- Planlegger og fasiliterer workshops, og utarbeider beslutningsnotater, ledelsesunderlag, dokumentasjon og onboarding for ledere, controllere, fagmiljøer og tekniske samarbeidspartnere.
- Utvikler beslutningsstøtte for økonomi, bemanning, aktivitet/DRG og pasientflyt med Power BI, DAX, Power Query, Excel/VBA, SQL og prosjektavhengig R/Python.

Barne- og ungdomsklinikken, Stab **03.2023-11.2023**

- Overtok etter opplæring den tildelte månedsoppgjørsflyten med periodisering, reversering, avstemming, kvalitetssikring, resultatforklaring og rapportering til ledere.
- Utviklet Excel/VBA-verktøy for konvertering og validering ved overgangen til REGERP og bidro i budsjett, prosjektøkonomi og klinikkens økonomi-/aktivitetsrapportering.

cv 2

UTDANNING

Masterprogram i kunstig intelligens | Universitetet i Agder 2024-d.d.
Pågående.

Master i samfunnsøkonomi | NTNU 2020-2022
Relevante fag: videregående og anvendt økonometri, anvendt tidsserieøkonometri og videregående matematisk analyse.

Bachelor i samfunnsøkonomi | Universitetet i Bergen 2017-2020
Bred økonomifaglig bakgrunn, blant annet statistikk og økonometri, offentlig økonomi, arbeidsmarked, konkurranse, finans og bedriftsøkonomi.

TIDLIGERE ERFARING

07.2015-08.2021 | Hjelpearbeider, TKS Heis. Sesong- og heltidsarbeid sammen med heismontører under studiene, i et praktisk og sikkerhetssensitivt arbeidsmiljø.
02.2015-04.2015 | Butikkmedarbeider/vikar, Ahlsell, Auglendsmyra. Arbeidet med varemottak, lager, bestilling, salg og kundekontakt.
03.2014-02.2015 | Vakt- og sikringssoldat, Luftforsvaret, Sola. Utførte vakthold, adgangskontroll og alarmrespons med tydelige prosedyrer og ansvar.
10.2013-03.2014 | Sikkerhetskonsulent, Sector Alarm. Gjennomførte behovsavklaring, pristilbud, direkte salg og kundedialog.

TILLITSVERV

Styremedlem/beboerrepresentant, Solheimslien studentboliger, 10.2017-01.2019.
Økonomiansvarlig og nestleder, 01.2019-01.2020.
Styreleder og økonomiansvarlig, 01.2020-08.2020.

SPRÅK

Norsk: Morsmål
Engelsk: Flytende skriftlig og muntlig

KURS

Sanitet nivå 2, 04.2014.

REFERANSER

Oppgis ved forespørsel.

letter 1

VEGARD HÅLAND
+47 905 26 886 · vegard-haaland@outlook.com
Oslo

Tolletaten Oslo, 20. september 2026

Søknad: Seniorrådgiver - Prosessledelse og endring

Som samfunnsøkonom og rådgiver i Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus arbeider jeg med behov som er uklare når de kommer inn, og som må ende i avgrensede leveranser, kontroller og arbeidsformer noen faktisk tar i bruk. Det er den veien Fremtidens tollbehandling skal gå: fra ambisjon til avklaringer, beslutninger og oppfølging på tvers av program, linje og eksterne aktører.

Sykehusets budsjetteringsverktøy er om lag 20 år gammelt og virksomhetskritisk, og hadde samlet teknisk gjeld i formler, navn, VBA og spredte arbeidsbokkopier. Bemanningsdata måtte kopieres fra en annen arbeidsbok, med mye manuelt arbeid og tilsvarende risiko ved endring. Om lag 50 personer deltok i arbeidsgrupper, kravdiskusjoner og innføring, og jeg var i praksis eneste utvikler på selve kodeendringene: jeg rekonstruerte arkitekturen fra kildekode, formler og navn, integrerte ansatt-, ansettelses- og bemanningsdata og ryddet opp i logikk som lå spredt mellom celler, navn og VBA.

Rammen var satt av innføringsansvarlig: endringene skulle gjøres funksjon for funksjon, selv om jeg anbefalte en bredere omstrukturering. Jeg gjennomførte moderniseringen innenfor den rammen, med differansesammenligning av opprinnelige og refaktorerte funksjoner, akseptansekriterier, eksplisitte paritetskrav og et risiko- og gap-register, og laget onboarding og presentasjonsmateriell for controllerne. Den moderniserte versjonen ble brukt sykehusdekkende i budsjettprosessen for 2026, og den avsluttende moderniseringen for 2027 er ferdigstilt og i bruk. Det foreligger ingen godkjente målinger av spart tid eller færre feil, men leveransen og bruken er dokumentert.

Gevinstrealisering har jeg arbeidet med som metode. Etter oppdrag fra ledelsen medutviklet jeg i en firepersonersgruppe et revidert rammeverk for gevinstrealisering og estimering, med bidrag til forskningssyntese, metodisk forbedring, økonomisk og strategisk analyse og standardisering. Rammeverket ble innført som sykehusstandard og var i bruk om lag 2,5 år senere. Mye av arbeidet gikk med til å samle ulike faglige perspektiver i én arbeidsform.

Arbeidsformen min starter med beslutningsproblemet: hvem som skal bruke resultatet, hva som faktisk må avklares, hvilke avhengigheter og risikoer som finnes, og hva som kan vente. Jeg har brukt den til å utforme strukturerte inntaksskjemaer som fanger formål, brukere, beslutningsbehov, avhengigheter, risiko og akseptansekriterier før løsningsarbeidet starter, til å beskrive ansvar, avhengigheter og prioritering i avdelingens arbeidsmodell, og til å planlegge og fasilitere workshops. Noen av arbeidsformene er innført, andre står som forslag. Underlaget tilpasser jeg mottakeren, enten det er ledere, controllere, fagmiljøer eller tekniske miljøer, og jeg sier fra når ansvar eller fremdrift er uklart.

Forenklingen av vareflyten må skje uten at noe ryker underveis, og det er den typen oppdrag jeg har lyst til å arbeide med videre. Sammenhengen er større og mer aktørrik enn den jeg står i nå, men avveiningen er kjent: forbedring må veies mot kontinuitet i en prosess som ikke kan stoppe. Der kan jeg bryte programmets ambisjoner ned til avklaringer, ansvar, milepæler og beslutningsunderlag. Jeg tar gjerne en samtale om det.

Med vennlig hilsen
Vegard Håland

sparebank1_omradearkitekt_kundetilbud_marked (r20260920-212518-413d77)

cv 1

VEGARD HÅLAND

RÅDGIVER ØKONOMI OG IKT | TEKNISK ARKITEKTUR, INTEGRASJON OG KONTROLLERT MODERNISERING

Oslo | +47 905 26 886 | vegard-haaland@outlook.com

PROFIL

Samfunnsøkonom med master fra NTNU, rådgiver i Analyseavdelingen ved Oslo universitetssykehus og med et pågående masterprogram i kunstig intelligens. Jeg designer løsningsarkitektur fra ende til ende: datamodell, integrasjoner, orkestrering, kontroller og dokumentasjon, og jeg holder antakelser, avhengigheter og teknisk gjeld synlige for dem som skal bruke og vedlikeholde løsningen. Arbeidet spenner fra en semantisk modell jeg bygget og driftet til avvikling, via modernisering av et virksomhetskritisk legacy-system som er i sykehusdekkende bruk, til den samlede arkitekturen i et pågående prognoseprosjekt. Økonomibakgrunnen gjør at tekniske valg blir vurdert mot hva de faktisk koster og gir av verdi.

KJERNEOMRÅDER Løsningsarkitektur og end-to-end design på prosjektnivå · Semantisk modellering: stjerneskjema, fakta- og dimensjonsskille, nøkler, hierarkier og periodelogikk · Dataintegrasjon og ETL med Power Query M, SQL, Excel/VBA og R/Python · Teknisk gjeld, regresjonskontroll og kontrollert endring i kritiske løsninger · Validering: tidsriktige holdout-sett, lekkasjekontroll, baselinjer og akseptansekriterier · Arkitekturdokumentasjon, sporbare antakelser og avhengighetsoversikt · Kontrollert bruk av KI- og kodeagenter med tester, sporbare overleveringer og menneskelig ansvar · Oversettelse mellom virksomhetsbehov, økonomi og tekniske valg

YRKESERFARING

Rådgiver Økonomi og IKT | Oslo universitetssykehus HF 03.2023-d.d.
Direktørens stab, Analyseavdelingen **12.2023-d.d.**

- Har ansvaret for den samlede løsningsarkitekturen, orkestreringen, automatiseringen og integrasjonen i et prognoseprosjekt for pasientvolum, sengebehov og kapasitet med 14, 90 og 365 dagers horisont. Prosjektet er i aktiv utvikling, ikke i produksjon; en kollega laget den opprinnelige XGBoost-modellen og ledet mye av datavalideringen, og implementeringen er fordelt mellom meg, kollegaen og kodeagenter.
- Krever tidsriktige holdout-sett, baselinjer, operative måltall og akseptansekriterier, og gjennomgår kode, konfigurasjon, avhengigheter, tester og eksponering av sensitive data.
- Utformet nesten hele den semantiske modellen, mesteparten av ETL-logikken i Power Query M og om lag 80 til 90 prosent av DAX-en i en styringsløsning bygget fra bunnen for økonomi, bemanning, sykefravær og aktivitet/DRG. Valgte stjerneskjema etter å ha vurdert alternativer opp mot egnethet i Power BI og vedlikeholdbarhet; kollegene ledet innholdsvalg og visuell utforming.
- Eide løsningen fra om lag august 2025 til februar 2026 med månedlig drift, veiledede tester med faktiske brukere og målrettede forbedringssprinter. Løsningen ble avviklet rundt februar 2026.
- Moderniserte sykehusets om lag 20 år gamle og virksomhetskritiske budsjetteringsverktøy: rekonstruerte arkitekturen fra kildekode, formler og navn, integrerte ansatt-, ansettelses- og bemanningsdata og gjennomførte endringene funksjon for funksjon med differansesammenligning, akseptansekriterier, paritetskrav og risiko- og gap-register. Jeg var i praksis eneste utvikler på kodeendringene, i en prosess med om lag 50 deltakere. Verktøyet er i sykehusdekkende bruk i budsjettprosessene for 2026 og 2027.

cv 2

- Utformet en proxybasert fordelingsmodell for gevinster i steril logistikk da datagrunnlaget ikke bar direkte måling: vektede indirekte indikatorer, synlige og konfigurerbare forutsetninger, skjemakontrollert overføring mellom fire grenmodeller og en konsolideringsmodell, og kontroller for umappede rader og skjemaavvik. Ferdigstilt og overlevert til controllere tidlig i 2026.
- Vurderer nye plattformmuligheter som Microsoft Fabric, Power Platform, dbt og Pega mot sykehusets faktiske rammer; dette er utforskende arbeid, ikke plattformeierskap.
- Utvikler beslutningsstøtte for økonomi, bemanning, aktivitet/DRG og pasientflyt, og formidler tekniske valg og konsekvenser til ledere, controllere, fagmiljøer og tekniske samarbeidspartnere.

Barne- og ungdomsklinikken, Stab **03.2023-11.2023**

- Overtok etter opplæring den tildelte månedsoppgjørsflyten med periodisering, reversering, avstemming, kvalitetssikring, resultatforklaring og rapportering til ledere.
- Utviklet Excel/VBA-verktøy for konvertering og validering ved overgangen til REGERP og bidro i budsjett, prosjektøkonomi og klinikkens økonomi-/aktivitetsrapportering.

UTDANNING

Masterprogram i kunstig intelligens | Universitetet i Agder 2024-d.d.
Pågående.

Master i samfunnsøkonomi | NTNU 2020-2022
Relevante fag: videregående og anvendt økonometri, anvendt tidsserieøkonometri og videregående matematisk analyse.

Bachelor i samfunnsøkonomi | Universitetet i Bergen 2017-2020
Bred økonomifaglig bakgrunn, blant annet statistikk og økonometri, offentlig økonomi, arbeidsmarked, konkurranse, finans og bedriftsøkonomi.

TIDLIGERE ERFARING

07.2015-08.2021 | Hjelpearbeider, TKS Heis. Sesong- og heltidsarbeid sammen med heismontører under studiene, i et praktisk og sikkerhetssensitivt arbeidsmiljø.
02.2015-04.2015 | Butikkmedarbeider/vikar, Ahlsell, Auglendsmyra. Arbeidet med varemottak, lager, bestilling, salg og kundekontakt.
03.2014-02.2015 | Vakt- og sikringssoldat, Luftforsvaret, Sola. Utførte vakthold, adgangskontroll og alarmrespons med tydelige prosedyrer og ansvar.
10.2013-03.2014 | Sikkerhetskonsulent, Sector Alarm. Gjennomførte behovsavklaring, pristilbud, direkte salg og kundedialog.

TILLITSVERV

Styremedlem/beboerrepresentant, Solheimslien studentboliger, 10.2017-01.2019.
Økonomiansvarlig og nestleder, 01.2019-01.2020.
Styreleder og økonomiansvarlig, 01.2020-08.2020.

SPRÅK

Norsk: Morsmål
Engelsk: Flytende skriftlig og muntlig

KURS

Sanitet nivå 2, 04.2014.

REFERANSER

Oppgis ved forespørsel.

letter 1

VEGARD HÅLAND
+47 905 26 886 · vegard-haaland@outlook.com
Oslo

SpareBank 1 Utvikling Oslo, 20. september 2026

Søknad: Områdearkitekt

Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom økonomi og teknologi: som samfunnsøkonom og rådgiver i Analyseavdelingen ved Oslo universitetssykehus designer jeg løsningsarkitektur og datamodeller, og jeg bruker økonomifaget til å vurdere hva et teknologivalg koster og gir. Jeg bygger slik at antakelser, avhengigheter og teknisk gjeld kan ettergås av andre enn den som laget løsningen.

I dag har jeg ansvaret for den samlede løsningsarkitekturen i et prognoseprosjekt for pasientvolum, sengebehov og kapasitet. Jeg designet repositoriet og arkitekturen, bygget orkestreringen som kobler data, features, modeller, evaluering og utdata, og står for mesteparten av automatikken rundt. Prosjektet er i aktiv utvikling og ikke satt i produksjon: en kollega laget den opprinnelige XGBoost-modellen, implementerte mange features og ledet mye av datavalideringen, og implementeringen er fordelt mellom meg, kollegaen og kodeagenter. Jeg definerte og utfordret den operative målvariabelen, krevde tidsriktige holdout-sett, baselinjer og akseptansekriterier, og undersøkte tidslekkasje, intervalloverlapp og feiljustering mellom features og målvariabel før resultater ble tolket.

Før dette bygget jeg hoveddelen av en styringsløsning for sykehuset fra bunnen. Jeg utformet nesten hele den semantiske modellen, mesteparten av ETL-logikken i Power Query M og om lag 80 til 90 prosent av DAX-en, og valgte stjerneskjema etter å ha vurdert alternativer opp mot egnethet i Power BI og vedlikeholdbarhet. Kollegene ledet innholdsvalg og visuell utforming. Jeg eide løsningen fra om lag august 2025 til februar 2026, driftet den månedlig, gjennomførte veiledede tester der jeg observerte hvor brukerne faktisk stoppet opp, og kjørte målrettede forbedringssprinter. Løsningen ble avviklet rundt februar 2026.

Teknisk gjeld har jeg håndtert i praksis. Sykehusets budsjetteringsverktøy er om lag 20 år gammelt og virksomhetskritisk, med logikk spredt mellom celler, navn og VBA. Jeg rekonstruerte arkitekturen fra kildekode, formler og navn og integrerte bemanningsdata som tidligere måtte kopieres manuelt. Rammen var satt av innføringsansvarlig: endringene skulle gjøres funksjon for funksjon, selv om jeg anbefalte en bredere omstrukturering. Jeg gjennomførte moderniseringen innenfor den rammen, med differansesammenligning av opprinnelige og refaktorerte funksjoner, eksplisitte paritetskrav og et risiko- og gap-register. Verktøyet er i sykehusdekkende bruk i budsjettprosessene for 2026 og 2027.

Arkitekturvalg må også tåle at datagrunnlaget ikke holder. Da jeg ble bedt om å fordele gevinster fra steril logistikk direkte mellom klinikker, avviste jeg den direkte målingen og utformet i stedet en proxybasert fordelingsmodell med vektede indirekte indikatorer og eksplisitt usikkerhet. Forutsetningene og vektene ble holdt synlige og konfigurerbare, og jeg holdt VBA bevisst utenfor kjernen slik at controllere og fagansvarlige kunne inspisere og justere modellen uten varig avhengighet av en utvikler. Modellen ble ferdigstilt og overlevert til controllere tidlig i 2026; hvordan den er tatt i bruk, og hvilke vekter som ble stående, vet jeg ikke.

Bank, CRM, markedsplattform og personaliserte kundereiser er nytt for meg, og arkitekturansvaret mitt har vært på prosjekt- og løsningsnivå, ikke for et helt tjenesteområde. Det jeg tar med meg, er en arbeidsform som holder avhengigheter, gjeld og konsekvenser av teknologivalg lesbare for dem som skal prioritere, og en økonomibakgrunn som gjør at valgene

itera_head_of_data_ai (r20260915-190926-020eaa)